ONEMA-POP-027 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-027 — Segurança na Avaliação de Risco de Suicídio
e Plano de Segurança em Telenfermagem

1. Identificação institucional

REVISÃO TÉCNICA DO RT

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a abordagem de segurança na avaliação de risco de suicídio e plano de segurança em telenfermagem em atendimento domiciliar ou digital, conforme a pertinência. Não substitui avaliação médica ou atendimento de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado. Triagem de segurança de pessoa com ideação suicida em teleatendimento; não substitui atendimento presencial de crise. Contraindicado manter cuidado eletivo quando presentes sinais de emergência ou quando o procedimento exceder a competência/estrutura disponível.

4. Materiais e fornecimento

Enfermeiro: canal de chamada ativo, contatos de emergência, protocolo de escalonamento; paciente: contato de pessoa de confiança quando possível.

5. Avaliação e preparo

Localização atual informada voluntariamente, telefone de retorno, estar sozinho, ideação, intenção, plano, acesso a meios e tentativa recente.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar nome, telefone de retorno e localização para eventual emergência; informar limites do atendimento

remoto.

2. Perguntar de modo direto e sem julgamento sobre ideação, plano, intenção, meios e tentativa recente.

3. Investigar intoxicação, agitação, psicose, impulsividade e presença de pessoa de apoio.

4. Se perigo iminente, manter conexão, acionar SAMU 192 e mobilizar apoio local conforme necessidade e normas

de privacidade.

5. Solicitar, quando seguro, afastamento colaborativo de meios letais; não instruir manejo físico arriscado.

6. Não usar pontuação ou rótulo baixo/médio/alto para dispensar atendimento.

7. Quando não houver perigo iminente, construir plano colaborativo com sinais de alerta, estratégias de

enfrentamento, contatos e acesso a serviço especializado.

8. Registrar avaliação, decisões, acionamentos, contatos e confirmação de transferência do cuidado.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Plano e intenção atuais, tentativa recente, intoxicação ou perda de contato com risco conhecido: ativar contingência de emergência; não encerrar por ausência de resposta.

8. Cuidados posteriores e orientações

Plano de segurança acessível à pessoa e rede de apoio autorizada; CVV 188 como suporte, nunca substituto do SAMU.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa e histórico, avaliação e sinais vitais pertinentes, achados objetivos, cada etapa executada e resposta, orientações, escalonamento/contatos, plano de retorno, identificação e assinatura do enfermeiro. Fotos somente com consentimento específico.

10. Referências rastreáveis

 NICE NG225 — Self-harm: assessment, management and preventing recurrence — https://www.nice.org.uk/guidance/ng225/chapter/recommendations

NOTA DE CONTROLE: referências identificadas e parcialmente conferidas; adequação à legislação brasileira, protocolos locais e

instruções de fabricante deve ser analisada pelo RT.